

ホルモン療法(内分泌療法)

分類・作用機序・長期服用の支援

1 薬剤の分類マップ

乳がん(エストロゲン) 受容体を遮断・エストロゲンを減らす	SERM(抗エストロゲン薬) タモキシフェン トレミフェン
	SERD フルベストラント イムルネストラント カミゼストラント
	アロマターゼ阻害薬 アナストロゾール レトロゾール エキセメスタン
性腺機能の抑制 卵巣・精巣のホルモン産生を止める	LH-RHアゴニスト リュープロレリン ゴセレリン GnRHアンタゴニスト(前立腺) デガレリクス
前立腺がん(アンドロゲン) 受容体を遮断・合成を阻害	抗アンドロゲン薬 ビカルタミド フルタミド
	ARシグナル阻害薬 エンザルタミド アパルタミド ダロルタミド アンドロゲン合成阻害薬 アピラテロン
併用薬・その他 効果の増強・骨の保護など	CDK4/6阻害薬(乳がん) パルボシクリブ アベマシクリブ 骨を守る薬 デノスマブ ゾレドロン酸
	黄体ホルモン(子宮体がん等) メドロキシプロゲステロン

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 長期服用中に多い副作用と対処

ほてり・発汗 起こりやすい薬 タモキシフェン、LH-RHアゴニスト、前立腺がんの治療全般 対処・生活の工夫 重ね着で調節、カフェイン・飲酒を控える 受診・連絡の目安 生活に支障が大きい時は相談	関節痛・こわばり 起こりやすい薬 アロマターゼ阻害薬 対処・生活の工夫 適度な運動、鎮痛薬の使い方を相談 受診・連絡の目安 やめなくなったら自己中断の前に相談	骨密度低下・骨折 起こりやすい薬 アロマターゼ阻害薬、LH-RHアゴニスト、前立腺がんの治療 対処・生活の工夫 骨密度検査、カルシウム・ビタミンD、運動、骨粗鬆症治療薬 受診・連絡の目安 背中や腰の急な痛み、転倒
静脈血栓塞栓症 起こりやすい薬 タモキシフェン、トレミフェン 対処・生活の工夫 長時間同じ姿勢を続けない、水分をとる 受診・連絡の目安 片足の腫れ・痛み、急な息切れは至急	子宮内膜の変化 起こりやすい薬 タモキシフェン 対処・生活の工夫 婦人科での定期的な確認 受診・連絡の目安 不正性器出血は受診	

3 副作用の特徴と発現時期

	開始	1週	1か月	3か月	1年	5年～
● フレア(LH-RHアゴニスト)	開始1～2週					
● ほてり・発汗	数週～治療中ずっと					
● 静脈血栓塞栓症(タモキシフェン)	開始後の早い時期に多い					
● 低K血症・肝機能(アピラテロン)	開始数か月は定期検査					
● 皮疹(アパルタミド)	開始数か月以内					
● 関節痛(アロマターゼ阻害薬)	数週～数か月					
● 骨密度低下・骨折	年単位で進行					
● 服薬の自己中断	年数とともに増加					

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. ホルモン療法はホルモンの産生と受容体を断つ治療。閉経状況と、乳がん・前立腺がんでの使い分けを押さえる
2. 年単位の継続が効果の鍵。ほてり・関節痛・骨の健康への対処で自己中断を防ぐ
3. アピラテロンの空腹時服用、エンザルタミド等の酵素誘導、タモキシフェンとCYP2D6阻害薬に注意